

Les aspects cytologiques du lymphome Hodgkinien à propos de six cas :

Pr.Aouati Bitat Ch /Pr zaim L/ Dr. Adjissi M/ Dr Daksi S/ Dr Behat. H . / Dr Bougharnout B / Dr Megaache .A /Dr.Lahmar.S/Dr.Kerouani.I
Service de Biologie cellulaire et Génétique médicale – CHU Saadna Abdenour, Sétif
Laboratoire de recherche de gé nétique médicale -Faculté de médecine ,Sétif

Introduction :

- Le lymphome Hodgkinien ou maladie de Hodgkin est une hémopathie lymphoïde fréquente représentant 5 à 10% de toutes les hémopathies malignes ; caractérisée par une infiltration, le plus souvent ganglionnaire par des cellules tumorales de Hodgkin et de Reed-Sternberg.
- L'incidence de la maladie en Algérie est de 1,8/100000/an
- Elle peut survient à tout âge mais elle est plus fréquente chez l'adulte jeune (20-40 ans)

OBJECTIF :

Evaluer et décrire les caractéristiques morphologiques de la cytologie (cytoponction ganglionnaire) dans l'orientation diagnostique du lymphome de Hodgkin à travers l'étude de 6 cas

MATERIELS ET METHODES

Prélèvement : Cytoponction à l'aiguille fine (CPAF) de masses ganglionnaires (principalement cervicales et sus-claviculaires).
Technique : Étalements cytologiques colorés au May-Grünwald-Giemsa (MGG) et/ou Papanicolaou
Lecture des étalements au microscope optique

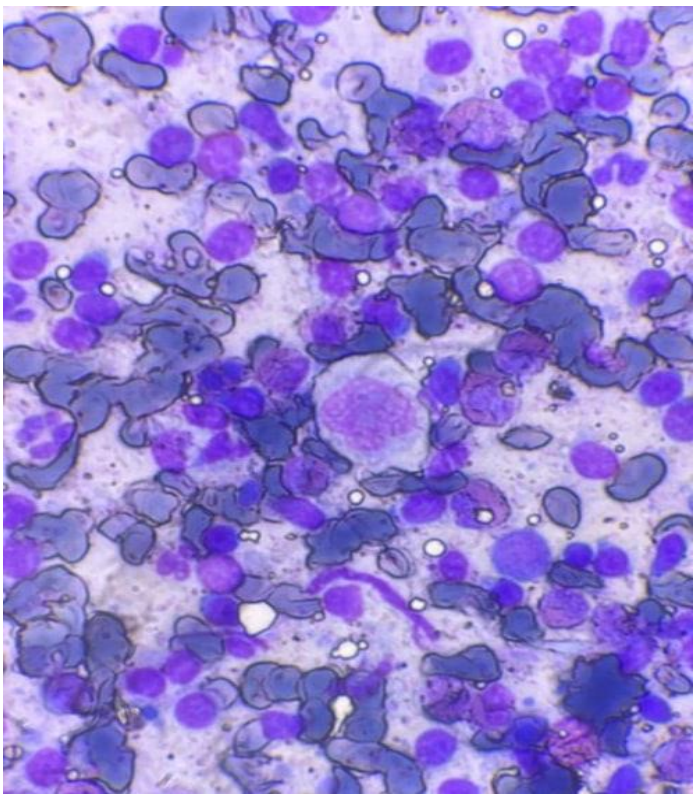


Figure 01 : Aspect cytologique du lymphome de Hodgkin : cellule de Hodgkin .

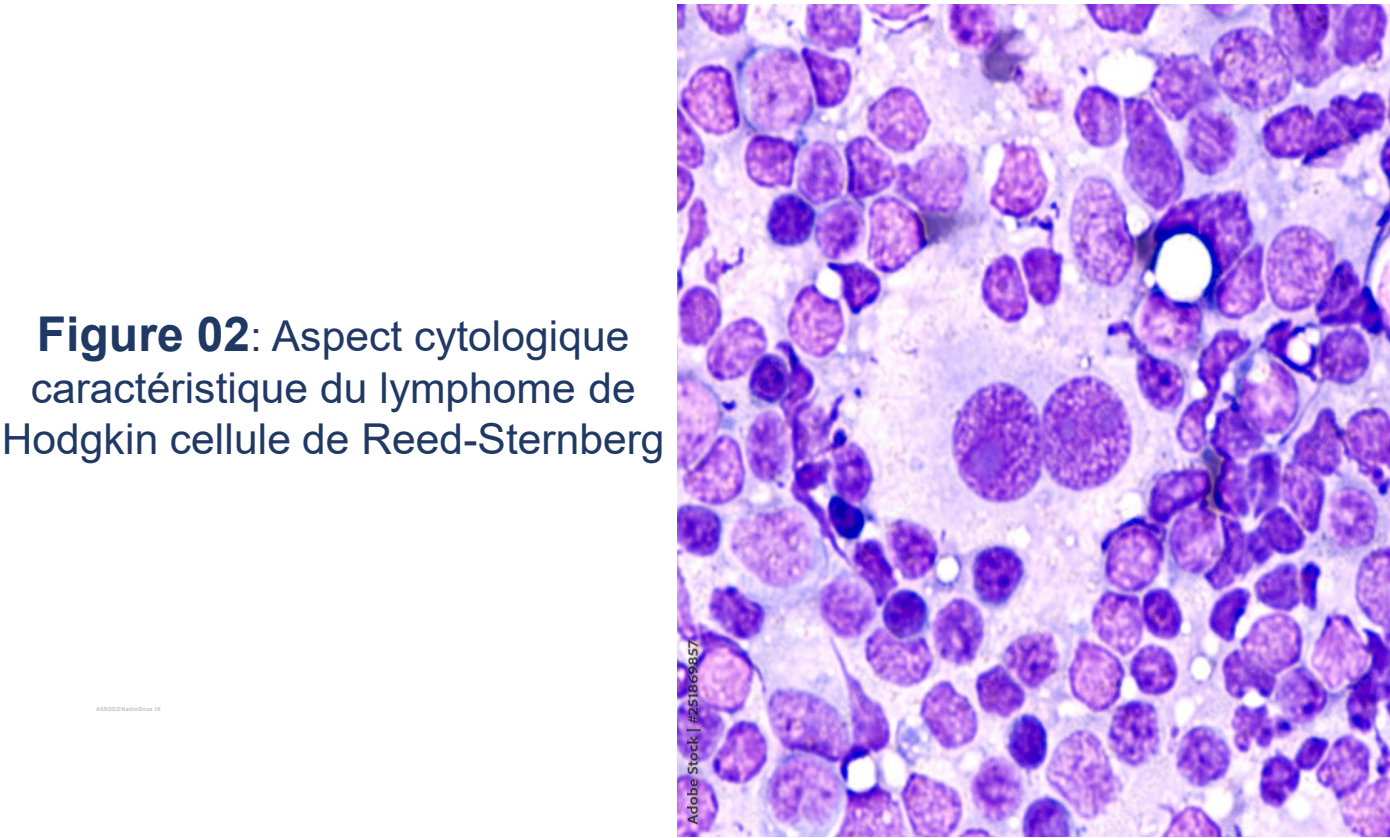


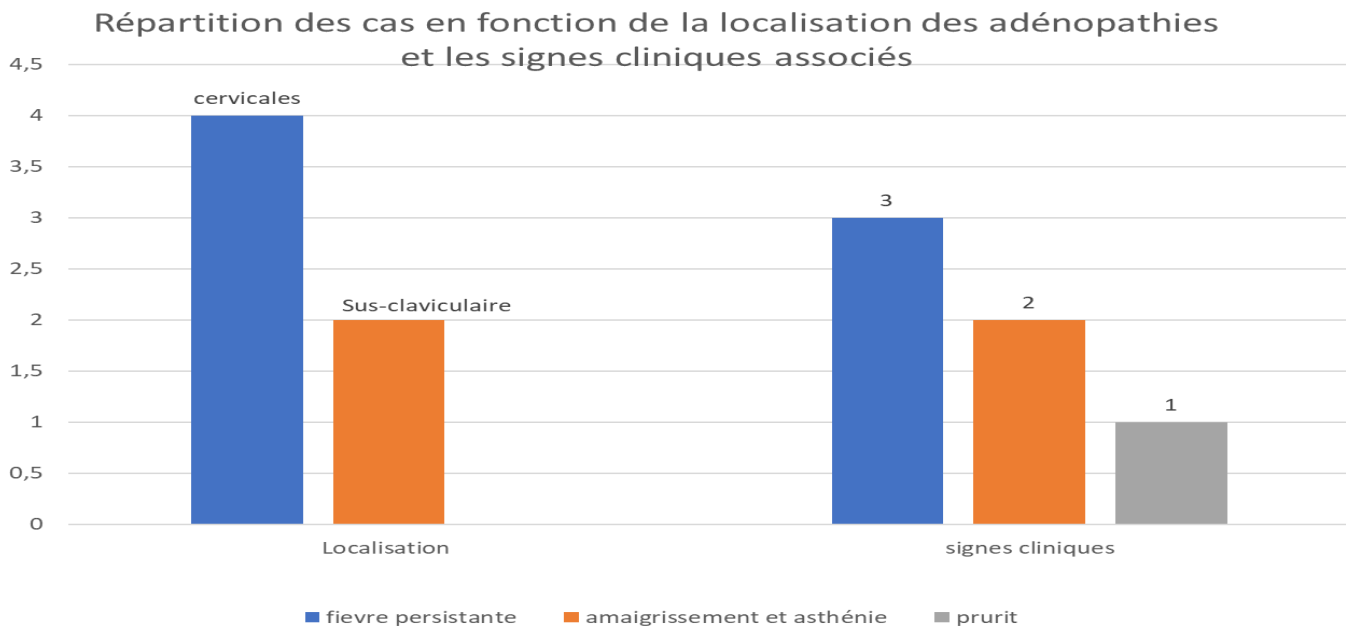
Figure 02: Aspect cytologique caractéristique du lymphome de Hodgkin cellule de Reed-Sternberg

Discussion :

Le lymphome de hodgkin classique est caractérisé par l'identification de cellules tumorales, la cellule de Reed-Sternberg caractéristique et des cellules de hodgkin, au sein d'un environnement bien particulier associant à des degrés variables des lymphocytes, une éosinophilie, des plasmocytes, des histiocytes et des cellules épithélioïdes. Les cellules tumorales représentent habituellement 0.1 à 10% des cellules du tissu atteint. La cytoponction à l'aiguille fine et l'étude cytologique des masses ganglionnaires cervicales ont été réalisé sur 06 patients consultant pour deux principaux motifs: la découverte d'adénomégalie à l'autopalpation ou des signes généraux (amaigrissement; asthénie, fièvre persistante, sueurs nocturnes profuses et prurit)
Selon les résultats:
Age moyen: 20-40 ans
Sexe ratio: prédominance féminine
Localisation des adénopathies : majoritairement cervicales (66.7% des cas) et sus claviculaires (33.3 % des cas)
Autres localisations des adénopathies: ADP médiastinales (33.3% des cas) ADP intra abdominales (16.7% des cas)
Signes cliniques associés : présence de fièvre persistante (50% des cas) amaigrissement et asthénie (33.3% des cas) prurit (16.7% des cas)
Aspect échographique évoquant: une adénopathie d'origine tuberculeuse (83.3% des cas) une adénopathie suspecte (16.7% des cas)
Adénopathies multiples bilatérales: 66.7% des cas
Adénopathies multiples unilatérales : 33.3% des cas
L'analyse cytologique au microscope optique de nos 6 cas met en évidence: La présence de cellule de Reed-Sternberg qui signe le diagnostic de lymphome hodgkin; correspond à une cellule géante (20 -50 µm) comportant un noyau volumineux, irrégulier, souvent binucléés ou multinucléés ,une chromatine fine caractéristique « œdématisée » avec un volumineux nucléole . Elle est présente dans (66.7% des cas)
La cellule de hodgkin: grande cellule à noyau unique, non segmente, chromatine fine avec un ou plusieurs nucléoles dont l'aspect est intermédiaire entre cellules de Reed-Sternberg et immunoblastes. Elle est mise en évidence dans (33.3% des cas)
Le fond réactif polymorphe (microenvironnement): l'arrière plan cellulaire est riche et témoigne de la réaction immunitaire de l'hôte

Conclusion :

L'analyse cytologique joue un rôle fondamental dans le dépistage et l'orientation diagnostique rapide du lymphome Hodgkinien en mettant en évidence le duo caractéristique : cellules géantes atypiques(Reed-Sternberg) et fond inflammatoire polymorphe



Références Bibliographiques :

- Lucile Basesgio . Frédéric Charlotte. Karim Maloum. Atlas de cytopathologie ganglionnaire.
- Stastny JF, Almeida MM, Wakely PE Jr, Kornstein MJ, Frable WJ. *Fine-needle aspiration biopsy and imprint cytology of small non-cleaved cell (Burkitt's) lymphoma. Diagnostic Cytopathology.*
- Orphanet (INSERM). Maladie d'Erdheim-Chester [Internet].; Consulté en Août 2026
- Lucile Basesgio, Frédéric Charlotte ;Atlas de cytopathologie; Mai 2022
- <https://cancer.ca/fr/cancer-information/cancer-types/hodgkin-lymphoma>
- <https://www.gustaveroussy.fr/fr/lymphome-hodgkin>